

DANILO DE JESUS VIEIRA		DN 09/06/83
MEDICAMENTOS:	lisartana (50mg)	
SINTOMAS/QUEIXAS	P = 115 Kg	
Banheiro	3 a 4x	Banheiro 4x à noite
HORA QUE DORME	1:30	
HORA QUE ACORDA	03:30	Eficiência 90,8%
SONECA DURANTE O DIA	às vezes 30'	IAH 89,9/h
HORARIO DAS REFEIÇÕES		
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE: JANTA:
28/02 P = 11 cmH ₂ O		
22 IAH = 1.0		
m. de uso: fha		
30/09 P = 11 cmH ₂ O		
22 IAH = 0.8 e/h		
m. de uso: 6h30'		
bem adaptado		
04/10 P = 11 cmH ₂ O		
22 IAH = 0.7 e/h		
m. de uso: 6h34'		
bem adaptado		
10/03 P = 11 cmH ₂ O		
23 IAH = 1.9 (hipopneia)		↓ Peso = 98 Kg
m. de uso: 6h17'		
bem adaptado, s/ queixas, s/ sonolência		
uso de lisartana 10mg - 1x noite.		
18/05/23 P = 11 cmH ₂ O		
23 IAH = 1.6 e/h		
m. de uso: 5h46'		
bem adaptado s/ queixas		
05/12/23 P = 11 cmH ₂ O		
IAH = 2.2 e/h.		bem adaptado.
fuga = 230 min.		→ todo filtro
m de uso: 6h04 min.		
23/02 P = 11 cmH ₂ O		
24 IAH = 2.3 e/h		Banheiro (ox) = 92 Kg.
m. de uso: 6h30'		
bem adapt., relata estar s/ sonolência		
07/06 Relata estar bem adaptado.		Peso: 91 Kg.
24 P = 11 cmH ₂ O		
IAH = 2.7 e/h		
m. de uso: 6h15'		
troca o filtro		
21/08/24 P = 11 cmH ₂ O		
IAH = 1.7 e/h		
m uso = 5h45		

Danilo de Jesus Vieira

À EMPRESA DE CPAP

Paciente com Roncos e Apnéia, sem melhora com tratamento clínico

Polissono:

Eficiência: 90,8%

Polissono com IAH - 89,9/h

Sat média 80%

Nadir: 54%

86,6% do tempo com sat abaixo de 90%

Microdespertares: 67,2/h

Fez titulação para avaliar necessidade de BIPAP, pressão sugerida de 11cmh20, no entanto, não zerou apnéia após chegar nesse limite de pressão.

Solicito avaliação para CPAP.

Grata,

ra. Priscila L. Silveira
Otorinolaringologista
CRM 140.497

Dr. Luiz Antonio da Silveira
Clínica Médica
CRM - 40.263 - RQE: 38744

Dr. Marina Leite da Silveira
Ortopedista
CRM 130.637 / RQE: 36404

Dr. Mateus Francisco S. Libardi
Ortopedia e Traumatologia
Especialista em Joelho
CRM - 143.110 / TEOT: 13337
RQE: 49194

Dr. Priscila Leite da Silveira
Otorinolaringologista
CRM - 140.497 / RQE: 40311

Nome: DANILO DE JESUS VIEIRA

Data de Nascimento: 9-6-1983

IMC: 42,76

Sexo: Masculino

Data do exame: 29-01-2022

Peso: 115 kg

Altura: 1,64 m

Médico: DRA. PRISCILA LEITE DA
SILVEIRA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 29-01-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 602,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 17,0 e 157,0 minutos. O tempo total de sono foi de 546,5, eficiência de 90,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,4%; estágio N2: 76,1%; estágio N3: 4,1%; sono REM: 18,4%. O índice de despertares foi de 67,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 89,9/hora, sendo elas 102 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 199 hipopnéias. A SpO2 média foi de 80% e mínima de 54%, permanecendo 86,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 35 - 107 bpm e NREM de 48 - 106 bpm.

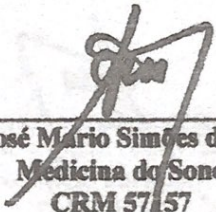
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (17), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 89,9/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO2=54%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: DANILO DE JESUS VIEIRA
Data de Nascimento: 9-6-1983
IMC: 42,76
Sexo: Masculino
Data do exame: 23-02-2022

Peso: 115 kg
Altura: 1,64 m
Médico: DRA. PRISCILA LEITE DA
SILVEIRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 23-02-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 542,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 6,0 e 146,5 minutos. O tempo total de sono foi de 452,5, eficiência de 83,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,8%; estágio N2: 54,7%; estágio N3: 19,4%; sono REM: 23,1%. O índice de despertares foi de 25,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 44,0/hora, sendo elas 164 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 168 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e mínima de 67%, permanecendo 22,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 50 - 93 bpm e NREM de 52 - 94 bpm.

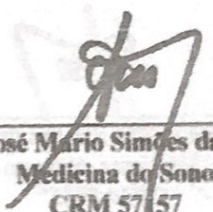
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (33,8/hora);
6. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 11,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157